

05 - 05- Les Schizophrénies - Pr. ADALI

Chers étudiants, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce cours sur les schizophrénies. Les objectifs de ce cours sont Expliquer les symptômes du syndrome dissociatif Expliquer les symptômes du syndrome délirant Expliquer les symptômes du syndrome autistique Diagnostiquer une schizophrénie constituée Citer les formes de début de la schizophrénie Citer les sous-catégories de schizophrénie en fonction des particularités cliniques Expliquer le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge Expliquer l'intérêt des mesures psychosociales Comme prérequis, vous êtes invité à réviser votre cours de sémiologie psychiatrique La schizophrénie est une maladie d'évolution chronique, interrompt le fonctionnement de l'individu. Les patients psychotiques sont de grands utilisateurs des services de soins.

Cependant, la schizophrénie reste entachée de multiples tableaux et suscite encore de nombreuses craintes irrationnelles, suscitent des idées inexactes, non seulement de la part du grand public, mais aussi de la part des soignants. La schizophrénie est souvent associée à la violence et à la folie, d'où le rejet et l'exclusion de ces patients. Il s'agit d'un nouveau portrait de Van Gogh qui était un patient schizophrène.

Je vous demande, à la fin de ce cours, de préciser les éléments de ce portrait qui oriente vers le diagnostic de schizophrénie chez le peintre. La prévalence de la schizophrénie est estimée à 1% sur la vie entière, avec un sexe ratio égal à 1. L'espérance de vie des patients schizophrènes est en moyenne de 10 ans inférieure à celle de la population générale. Ce taux de mortalité élevé peut être expliqué soit par le suicide, soit par la comorbidité avec des pathologies somatiques liées à une mauvaise hygiène de vie.

Du point de vue sémiologique, on note l'association à des degrés d'intensité différents de trois grands syndromes. Le syndrome dissociatif, le syndrome délirant et le syndrome autistique. Le syndrome dissociatif correspond à la perte de l'unité psychique dont le résultat est une incohérence entre pensée, langage, comportement et émotions.

La dissociation se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau intellectuel, on note les troubles de la pensée comme les troubles du cours de la pensée, barrages, fadines, diffluences. Je vous demande de vous référer à votre cours de sémiologie psychiatrique.

Les troubles du contenu de la pensée comme l'ambivalence, les idées parasites et l'automatisme mental. Dans l'automatisme mental, les patients ont l'impression de ne plus maîtriser leurs propres pensées ou leurs propres sentiments. Quant aux barrages, les patients peuvent avoir l'impression que leur pensée s'arrête.

Le sentiment d'avoir le cerveau en pause. Il faut noter que les troubles de la pensée restent difficilement communicables et compréhensibles. Ce qui accentue l'isolement des patients schizophrènes.

Vous savez pertinemment que le langage reflète la pensée. En effet, la désorganisation de la pensée aboutit à un discours vague, incompréhensible, vide de sens. Les réponses peuvent être hors de tout propos.

Au maximum, le discours peut devenir hermétique avec des néologismes qualifiés de schizophrènes. Autres troubles de la sphère intellectuelle sont décrits. Les troubles du jugement et du raisonnement.

Les troubles de l'attention, de la concentration. Ce qui augmente les difficultés de scolarisation chez les jeunes patients. Les troubles de la pensée et du langage augmentent les difficultés de communication chez les patients.

Au niveau de la vie affective, les patients souffrent de difficultés à exprimer et à partager leurs émotions. Ils peuvent aussi souffrir d'une ambivalence affective. C'est-à-dire éprouver en même temps deux émotions contradictoires.

Des intérêts froids affectifs. Exemple de l'hostilité vis-à-vis des parents et en même temps les patients paraissent incapables de vivre sans eux. Au niveau instinctuel, on note une régression instinctivo-affective.

Source de perversions sexuelles, de masturbations pathologiques et autres. En outre, des troubles alimentaires sont décrits dans la schizophrénie, comme anorexie et piquant. Au niveau comportemental, on note plusieurs troubles.

Indécision des gestes, stéréotypes gestuels, des raptus impulsifs, automutilation, conduite suicidaire, fugue pathologique et syndrome catatonique. La dépersonnalisation est un symptôme très régoissant pour les patients. C'est un sentiment de perte de l'intégrité du corps et de l'identité.

Étrangeté, modification, transformation et morcellement du corps, c'est-à-dire avoir le corps en morceaux. Signe de miroir, le patient voit son visage changer au niveau du miroir. Parfois, il ne se reconnaît pas au miroir.

Sentiment de dédoublement et autres. Quant à la déréalisation, c'est la perte du sentiment de réalité et de familiarité. Après le syndrome dissociatif, on passe maintenant au syndrome autistique.

Il est marqué par le repli social et l'isolement. Avec réduction de l'activité. Passer un grand nombre d'heures à ne rien faire devant la télévision, à fumer ou à s'allonger sur son lit.

D'autres activités de la vie courante sont laborieuses comme entretenir son ménage ou même changer ses vêtements ou se laver. Dans la schizophrénie, le délire est de type paranoïde, flou, non systématisé. Les thèmes délirants sont multiples, de persécution, référence, filiation,

mystique et autres.

Un mécanisme multiple aussi, surtout hallucinatoire. Une participation émotionnelle forte peut être notée, à type d'angoisse. Avec risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.

En plus des trois grands syndromes précédemment décrits, d'autres troubles peuvent exister. Anxiété et angoisse, dépression, trouble du sommeil, trouble du comportement à type d'agressivité et violence, justifiant parfois le recours à l'hospitalisation et à abus de substances. Ce schéma illustre une autre description des symptômes de la schizophrénie.

En symptômes positifs, regroupant délire, hallucination visuelle et auditive, discours désorganisé, désorganisation de la pensée. Et symptômes négatifs regroupant retrait social, perte de motivation, désorganisation du mode de vie et perte de la joie de vivre. Plusieurs formes cliniques de la schizophrénie sont décrites en fonction de la prédominance de l'un ou l'autre des trois grands syndromes.

Dans la schizophrénie paranoïde, il y a une prédominance du délire et hallucination. La schizophrénie désorganisée avec comportement, affect et discours désorganisé. La schizophrénie catatonique avec prédominance du syndrome déficitaire.

La schizophrénie indifférenciée est une forme ne répondant pas aux critères des autres types. Dans la schizophrénie résiduelle, on note une persistance d'une forme atténuée des symptômes. Concernant le trouble schizoaffectif, les épisodes décrits correspondent aux critères de la schizophrénie.

Mais en même temps, on note un tableau répondant aux critères de la dépression ou de la maladie. Il existe deux formes de début, brutale et progressif. Dans la forme à début progressif, le début se fait sur 6 mois ou plus.

Les prodromes correspondent à la première phase de la maladie, caractérisé par des signes vagues difficiles à détecter. Il s'agit de changements dans les pensées, les émotions et les perceptions. On note un retrait social, un isolement, une négligence de l'hygiène, de l'apparence, un manque de motivation ou d'intérêt, des troubles cognitifs tels les troubles de l'attention, de la mémoire et des fonctions exécutives.

Dans la phase prodromique, on note aussi des troubles du sommeil, des croyances bizarres aux pensées magiques, de la suspicion, des états dépressifs, gestes suicidaires, actes de délinquance, violences et changements brusques d'intérêt. Le dépistage des prodromes de la schizophrénie est difficile, vu qu'il s'agit de symptômes non spécifiques. Le diagnostic est fait rétrospectivement et il n'existe pas de traitement reconnu.

Il existe des formes à début brutal, sous forme d'accès psychotique aigu, avec fréquence des facteurs de mauvais pronostic, qu'on va détailler dans le chapitre accès psychotique aigu. Ou des

troubles de l'humeur atypiques, comme une manie atypique, dépression atypique ou état mixte atypique. Je vous demande de vous référer à votre cours sur les troubles de l'humeur.

On passe maintenant à l'éthiopathogénie. D'abord, les facteurs génétiques. Plusieurs gènes de prédisposition, de vulnérabilité ou de susceptibilité interagissent pour aboutir à l'expression de la maladie.

La composante génétique de la schizophrénie est multigénique. Son mode de transmission est incertain. L'hypothèse neurobiologique reste toujours d'actualité, plaidant pour un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, avec implication du système méso-corticolimbique, cortex frontal, noyau lécentral et amygdale.

Dans l'hypothèse neurodéveloppementale, on évoque l'existence d'anomalies précoces, génétiques, gestationnelles ou périnatales, qui restent pour l'essentiel latentes jusqu'à la puberté ou au début de l'âge adulte. Les modèles d'interaction gène-environnement sont prometteurs dans la détermination de l'éthiopathogénie de la schizophrénie. Parmi les facteurs environnementaux précipitants, on citera l'exemple du cannabis.

La synthèse des données souligne l'existence d'un modèle complexe, polygénique et multifactoriel de la maladie. Ce schéma explique l'hypothèse neurobiologique. Par exemple, une hyperdopaminergie épisodique serait à l'origine des symptômes positifs de la schizophrénie, tandis qu'une hypofrontalité ou hypodopaminergie serait à l'origine des symptômes négatifs.

La schizophrénie évolue par poussées, qu'on appelle poussées processuelles. Des périodes de perturbations où les symptômes sont nombreux et intenses, et des périodes où les symptômes sont soit absents, soit présents mais mineurs. On distingue 4 phases.

La rechute correspond à la réapparition des symptômes psychotiques. Elle est souvent provoquée par l'arrêt du traitement, mais aussi par les événements stressants de la vie. Les premiers symptômes de la rechute sont repérés par l'entourage, rarement par le malade.

Parmi les complications graves de la schizophrénie est le suicide. Il est 30 fois plus élevé que dans la population générale. Il peut résulter du vécu douloureux qu'engendre la maladie.

C'est le schéma de l'histoire naturelle de la schizophrénie, ou les stades de la schizophrénie. En objectif, la phase saine ou pré-morbide, la phase prodromique, la phase active ou processuelle, et la phase résiduelle de stabilité. Les facteurs de bon pronostic dans la schizophrénie sont les formes paranoïdes ou schizoaffectives, le début tardif plus de 35 ans, le mode de début aigu, une bonne adaptation pré-morbide, c'est-à-dire avant l'apparition des premiers symptômes, une bonne réponse au neuroleptique, la coopération du patient et son entourage, et la précocité de la prise en charge.

Les diagnostics différentiels des formes à début aiguës sont l'accès psychotique aigu, les

troubles de l'humeur. Dans les formes à début progressif, les diagnostics différentiels sont le délire chronique non dissociatif, les troubles bipolaires. Dans les formes catatoniques, il faut éliminer une origine organique, notamment la tumeur cérébrale, par une IRM cérébrale et un examen clinique.

Le but du traitement est de réduire les symptômes, aider le patient à prendre conscience de sa maladie et à accepter le traitement, préserver les capacités cognitives et les capacités d'adaptation du patient, autonomie et qualité de vie, prévenir les rechutes, assurer un soutien de l'entourage. Notez bien que plus on traite précocement, mieux est le pronostic. Quels sont les débits dans la prise en charge de la schizophrénie ? D'abord, le manque de conscience de la maladie ou absence d'insight.

Cela entraîne une adhésion partielle au traitement. La consommation de substances, surtout le cannabis. L'arrêt fréquent du traitement est un facteur de résistance.

En effet, plus il y a d'épisodes psychotiques, moins le traitement est efficace. En outre, chaque fois qu'un patient rechute, il récupère plus lentement. Les moyens thérapeutiques dont on dispose pour traiter la schizophrénie sont des moyens médicamenteux et non médicamenteux.

Les traitements médicamenteux de choix dans la schizophrénie sont les neuroleptiques, qu'ils soient classiques ou atypiques. Les neuroleptiques atypiques sont la pierre angulaire du traitement de la schizophrénie. Ils sont aussi efficaces que les classiques dans le traitement des symptômes positifs, tels le délire et la dissociation, mais ils ont une plus grande efficacité sur les symptômes négatifs, par exemple les troubles cognitifs.

Mais ils ont aussi moins d'effets secondaires extrapyramidaux par rapport aux neuroleptiques classiques. Quant aux neuroleptiques classiques, ils sont prescrits en deuxième intention à cause des effets secondaires extrapyramidaux. D'autres traitements peuvent être utilisés.

Antidépresseurs si des pressions associées, anxiolytiques et anxiétés ou états. Thymorégulateurs dans le trouble schizoaffectif. Les moyens thérapeutiques non médicamenteux englobent la remédiation cognitive, qui est une technique psychothérapeutique destinée à améliorer les performances des patients en termes de mémoire, d'attention, de concentration et d'organisation de leurs actions.

La thérapie psychoéducative vise à enseigner aux patients les causes de sa maladie, les différentes options de traitement possibles, lui donner les ressources pour mieux la gérer et pour prévenir la survenue d'un nouvel épisode. Le médecin généraliste ou de famille joue un rôle important dans ce type de thérapie. La thérapie cognitive ou comportementale, ou TCC, vise principalement le développement de nouvelles compétences sociales et relationnelles, encourage les patients à parler librement de leurs croyances, émotions et expériences avec un thérapeute et enfin aide à développer les moyens pour faire face aux pensées négatives et aux problèmes du comportement.

Les programmes de réhabilitation visent à améliorer les habiletés sociales et permettent une meilleure intégration sociale. Par exemple, les allocations adultes handicapées, les formations professionnelles adaptées aux patients, l'hôpital de jour et la conception d'environnements protégés et adaptés, qu'on appelle les appartements thérapeutiques. L'électroconvulsivothérapie et la stimulation magnétique transcranienne sont indiquées dans la prise en charge des épisodes catatoniques ou résistants au traitement.

Les indications de l'hospitalisation sont l'établissement d'un diagnostic en début de maladie, en cas de poussée processuelle grave et quand il y a un risque suicidaire ou hétéroagressif. Quel est le rôle du médecin généraliste ou de famille en complémentarité avec le psychiatre? D'abord, c'est une personne de confiance pour le patient et son entourage. Il a souvent accès à plus d'informations par rapport au spécialiste.

Il joue un rôle important dans le dépistage précoce des troubles psychotiques. Il assure un suivi somatique du patient. En effet, les problèmes de santé physique des patients schizophrènes sont souvent sous-évalués et parfois non diagnostiqués ou traités d'une manière insuffisante puisqu'il s'agit de patients qui verbalisent très peu leurs symptômes.

Un travail spécifique est nécessaire pour promouvoir une meilleure hygiène de vie chez ces patients. Le médecin généraliste évalue l'accomplissement de son traitement et reconnaît précocement l'issue d'une rechute. En conclusion, dans la prise en charge de la schizophrénie, l'objectif ultime reste l'intégration du patient dans la société à travers son réseau familial et socio-professionnel.

Le dépistage précoce et la mise en place rapide d'un traitement sont deux éléments importants pour améliorer le pronostic. Je vous remercie.